SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE TABACOLOGIE

POUR UN PARCOURS PATIENT SÉCURISÉ

SFAR



PAS DE TABAC EN PERI-OPERATOIRE

Quels sont les bénéfices prouvés de l’arrêt préopératoire du tabac ?

Arrêt du tabagisme 6–8 semaines avant l’intervention entraîne la disparition du risque de complications opératoires dues au tabac

Arrêt un peu plus tardif 3–4 semaines avant l’intervention apporte sur tous les paramètres opératoires un bénéfice

Arrêt moins de 3 semaines avant l’intervention est globalement bénéfique car la diminution documentée des complications au niveau du site opératoire et cardiovasculaire relativise le risque controversé de majoration transitoire des complications respiratoires lors d’un arrêt une à deux semaines avant une intervention

Arrêt 12–48 heures avant une intervention permet une baisse du CO circulant et donc une meilleure oxygénation

Poursuite de l’arrêt du tabac durant le temps nécessaire à la cicatrisation (2–4 semaines) et éventuellement à la consolidation osseuse (**2–4 mois**) favorise les suites opératoires

Le conseil d’une simple réduction de la quantité de tabac fumé sans substitution nicotinique avant une intervention n’est pas recommandé.

POUR EN SAVOIR PLUS

Recommandations sur la prise en charge du tabagisme en période périopératoire